Allegra-D

Mais que um descongestionante:
eficácia comprovada, segurança garantida



Allegra® D é uma combinação de cloridrato de fexofenadina (60 mg) e cloridrato de pseudoefedrina (120 mg), indicada para o alívio temporário da congestão nasal decorrente do resfriado comum em pacientes com rinite alérgica.[1]

Allegra® D apresenta boa tolerância e perfil de segurança[1-5]

FEXOFENADINA

- Sem efeitos colinérgicos;[2]
- Sem efeitos cardiotóxicos.[2]

PSEUDOEFEDRINA

- Sem impacto significativo na pressão arterial e a frequência cardíaca;[3,4]
- Seguro para a maioria dos pacientes com hipertensão controlada.[3,4]

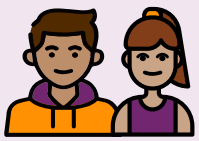
Estudo clínico com pacientes tratados com **Allegra® D.**[5]

>99% dos pacientes **não** apresentaram taquicardia[5]

Eletrocardiograma: sem efeito clinicamente significativo[5]

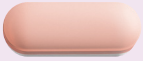
Allegra® D tem posologia prática[1]

A **tecnologia de liberação prolongada** prolonga os efeitos antialérgicos e descongestionantes de **Allegra® D.**[1,6]



ADULTOS E CRIANÇAS MAIORES DE 12 ANOS[1]

→



1 COMPRIMIDO 2X AO DIA

Para garantir a eficácia do tratamento e minimizar possíveis efeitos adversos, é essencial seguir as orientações de uso corretamente.[1,7*]

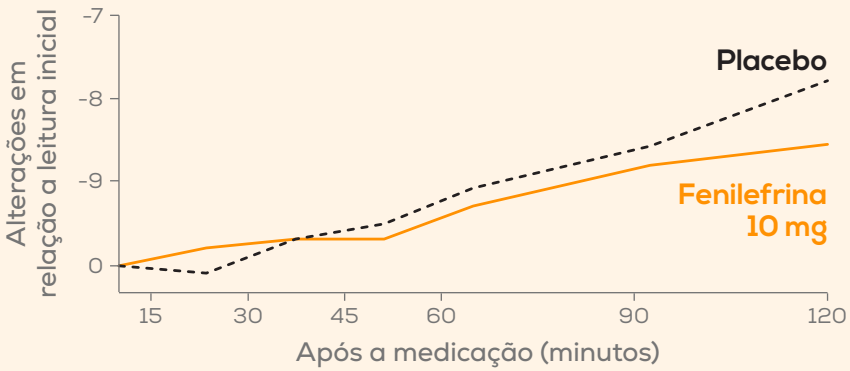
*Indicada especialmente quando há obstrução nasal persistente, a associação é recomendada como terapia de curto prazo ou de resgate, considerando riscos e benefícios individuais.[7,8]

Allegra® D entrega o que outros descongestionantes nasais prometem[6,9]

*A **Fenilefrina** teve sua eficácia questionada por autoridades de saúde e, em novembro de 2024, a FDA propôs sua remoção como ingrediente ativo em medicamentos de venda livre para congestão nasal.[9]*

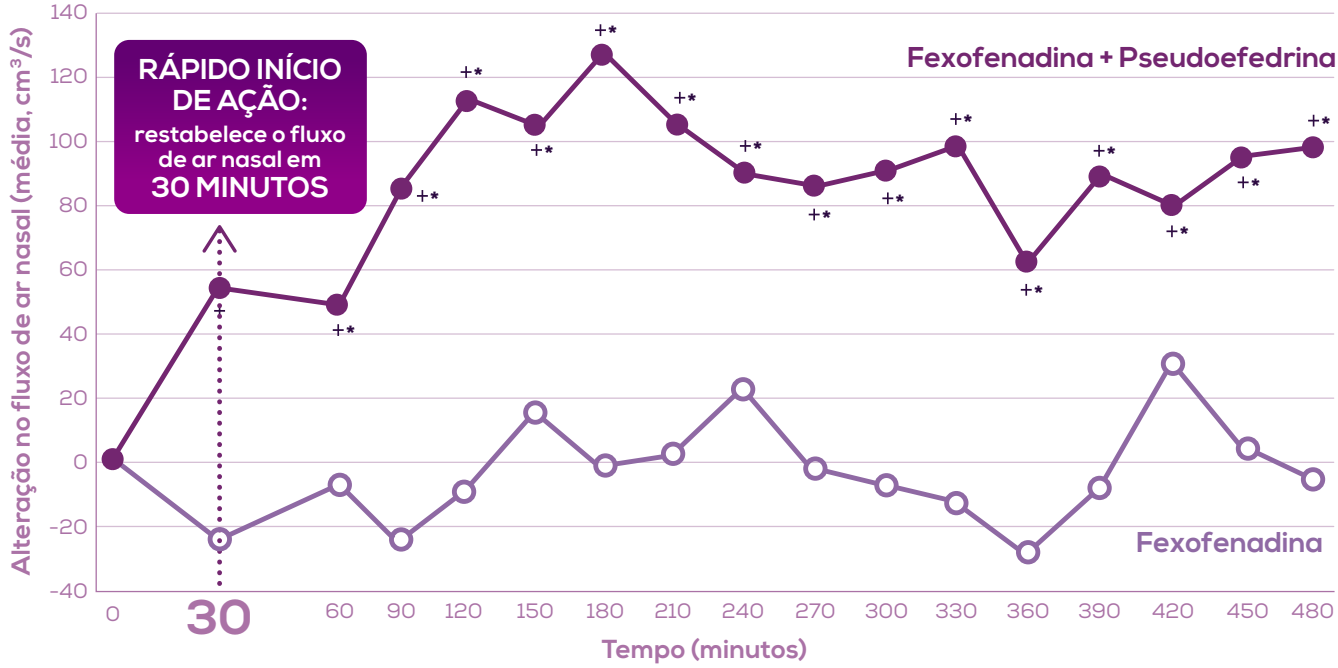
A Fenilefrina Oral não é mais eficaz do que um placebo no alívio da congestão nasal.[8,9]

Efeito descongestionante nasal em 15 indivíduos com resfriado comum



Allegra® D tem eficácia comprovada[1,6]

A associação de fexofenadina e pseudoefedrina é mais eficaz do que os componentes isolados.[6-8]



Adaptado de Nakamura et al. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021;21.[6]

Referências: 1. Bula Allegra® D. 2. Naclerio RM, Ansotegui IJ, Canonica GW, et al. Twenty-five years: The fexofenadine clinical experience. World Allergy Organ J. 2024;17(9):100950. 3. Beck RA, Mercado DL, Seguin SM et al. Cardiovascular Effects of Pseudoephedrine in Medically Controlled Hypertensive Patients. Arch Intern Med. 1992; 152:1242-1245. 4. Mores N, Campia U, Navarra P et al. No cardiovascular effects of single-dose pseudoephedrine in patients with essential hypertension treated with b-blockers. Eur J Clin Pharmacol. 1999; 55:251-254. 5. Sussman GL, Mason J, Compton D et al. The efficacy and safety of fexofenadine HCl and pseudoephedrine, alone and in combination, in seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 1999; 104(1):100-6. 6. Nakamura Y, Yokoyama Y, Koyama S et al. Effect of fexofena- dine/pseudoephedrine combination tablet on nasal obstruction in patients with allergic rhinitis using rhinomanometry: A randomized controlled trial. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021. doi: 10.12932/AP-160920-0963. 7. Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF). V Consenso Brasileiro sobre Rinites. São Paulo: ABORL-CCF; 2024. Acesso em 03 de abril de 2025. Disponível em: https://asbai.org.br/v-consenso-brasileiro-sobre-rinites/. 8. Dykewicz MS et al. Rhinitis 2020: A pratique parâmetro update. J Allergy Clin Immunol. 2020 Oct;146(4):721-767. 9. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Scientific Review Supporting Proposed Administrative Order OTC000036: Amending OTC Monograph M012 for Oral Phenylephrine. Silver Spring, MD: FDA; 2023. Available from: https://www.regulations.gov/document/FDA-2023-N-3306-0001.

ALLEGRA® D (cloridrato de fexofenadina e cloridrato de pseudoefedrina). **Indicações:** alívio dos sintomas de congestão das vias aéreas superiores, e também decorrente do resfriado comum em pacientes com rinite alérgica. **Contraindicações:** em pacientes com hipersensibilidade conhecida a fexofenadina, pseudoefedrina ou a qualquer componente da fórmula. A pseudoefedrina está contraindicada em pacientes com hipertensão arterial grave ou coronariopatia grave, glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária, ou naqueles que demonstraram sensibilidade aos agentes adrenérgicos; em pacientes sob tratamento com inibidores da monoaminoxidase ou dentro de 14 dias após a interrupção de tal tratamento. **Cuidados, advertências e reações adversas:** A pseudoefedrina pode produzir estimulação do SNC com convulsões ou colapso cardiovascular e deve ser utilizada com cautela em pacientes com diabetes *mellitus*, hipertensão, doença cardíaca isquêmica, pressão intraocular aumentada, hipertiroidismo, hipertrofia prostática, doença renal e hiperreatividade à efedrina. Podem ocorrer: cefaleia, sonolência, vertigem, náuseas, nervosismo, fraqueza, insônia, anorexia, taquiarritmia, palpitação, colite isquêmica, ansiedade, tensão, tremor, alucinação, palidez, dificuldade respiratória e urinária. ALLEGRA D não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação a menos que a relação risco/benefício seja avaliada pelo médico e supere os possíveis riscos para o feto ou criança. **Interações medicamentosas:** A administração de um antiácido contendo hidróxido de alumínio e magnésio, aproximadamente 15 minutos antes do cloridrato de fexofenadina, causou uma redução na biodisponibilidade. O uso concomitante de pseudoefedrina com drogas anti-hipertensivas que interferem na atividade simpatomimética (como por exemplo: metildopa, mecamilamina e reserpina) podem reduzir os seus efeitos anti-hipertensivos. O uso concomitante de pseudoefedrina com agentes simpatomiméticos pode provocar efeitos cardiovasculares adicionais. **Posologia:** 1 comprimido, duas vezes ao dia. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**. Registro MS 1.8620.0001. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

MAT-BR-2500304 - Maio/2025

Opella.

A unidade de consumo na Sanofi agora é Opella